TOME 14 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Douleur & Anesthésie

Collège des Enseignants d'Anesthésie-Réanimation & Douleur (CNEAR/SFETD) • 210 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 14 : Douleur & Anesthésie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 210 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège des Enseignants d'Anesthésie-Réanimation & Douleur (CNEAR/SFETD).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	210 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 14

Collège des Enseignants d'Anesthésie-Réanimation & Douleur (CNEAR/SFETD) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 14 • Douleur & Anesthésie (210 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Douleur : Physiopathologie et Évaluation (134)
- Chapitre 02 : Antalgiques (135)
- Chapitre 03 : Douleur chez l'enfant (137)
- Chapitre 04 : Douleur chez la personne vulnérable (138)
- Chapitre 05 : Soins palliatifs pluridisciplinaires (139, 140, 141)
- Chapitre 06 : Soins palliatifs en réanimation (143)
- Chapitre 07 : Soins palliatifs en pédiatrie (142)
- Chapitre 08 : Anesthésie (136)
- Chapitre 09 : Abords veineux (229)
- Chapitre 01 — Douleur : Physiopathologie et Évaluation (134)
- Définitions
- Définition : Douleur, Nociception, Souffrance
- Douleur aiguë vs Douleur chronique
- Hyperalgésie vs Allodynie
- Focus
- Bases neurophysiologiques de la douleur
- Physiopathologie de la douleur inclut 4 processus :
- Schéma
- Voies de la douleur
- Mécanismes périphériques de la douleur aiguë
- Relais spinal de la corne dorsale
- Schéma
- En pré-synaptique :
- Neurones post-synaptiques de la corne dorsale :
- Structures supra-spinales mises en jeu dans la douleur
- Mécanismes de contrôle de la douleur
- Généralités

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Douleur : Physiopathologie et Évaluation (134)
Chapitre 02 : Antalgiques (135)
Chapitre 03 : Douleur chez l’enfant (137)
Chapitre 04 : Douleur chez la personne vulnérable (138)
Chapitre 05 : Soins palliatifs pluridisciplinaires (139, 140, 141)
Chapitre 06 : Soins palliatifs en réanimation (143)
Chapitre 07 : Soins palliatifs en pédiatrie (142)
Chapitre 08 : Anesthésie (136)
Chapitre 09 : Abords veineux (229)

Chapitre 01 — Douleur : Physiopathologie et Évaluation (134)

Définitions

Définition : Douleur, Nociception, Souffrance
Douleur aiguë vs Douleur chronique
Hyperalgésie vs Allodynie

Focus

Bases neurophysiologiques de la douleur

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Douleur & Anesthésie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Définition	Expérience désagréable, sensorielle et émotionnelle, associée ou ressemblant à ce qui est associé à une lésion tissulaire réelle ou potentielle
Notes clés	- Douleur est toujours une expe■rience personnelle, influence■e a■ des degre■s divers par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux - Douleur et la nociception sont des phe■nome■nes diffe■rents, la douleur ne peut e■tre seulement lie■e a■ l'activite■ des neurones sensoriels - Individus appre■hendent le concept de la douleur a■ travers leurs expe■riences de vie - Rapport qu'une personne fait de son expe■rience de la douleur doit e■tre respecte■ - Bien que la douleur joue ge■ne■ralement un ro■le adaptatif, elle peut avoir des effets ne■gatifs sur la fonction et le bien-e■tre social et psychologique
Objectiver la douleur	Il ne faut pas chercher à objectiver la douleur pour la confirmer : - Il n'y a pas de biomarqueur de la douleur - Conséquences physiologiques (ex. tachycardie), Activation des aires cérébrales en imagerie : ne sont que partiellement corrélées à l'expérience
Douleur aiguë	Douleur aigue■ est au de■part un signal d'alarme qui met en jeu des re■flexes de protection nous permettant de : - Nous soustraire aux stimuli nocifs - Soulager les parties de notre corps soumises a■ de trop fortes tensions On appelle ce stimulus sensoriel initial, le stimulus nociceptif pe■riphe■rique
Douleur chronique	Envisage■e comme une situation ou■ le signal d'alarme continue a■ fonctionner, alors que le danger (stimulus nociceptif) a disparu : - Ensemble de phe■nome■nes pe■riphe■riques mais surtout centraux se sont enclenche■s de fac■on autonome et vont se pe■renniser - Me■me si les phe■nome■nes de nociception re■gressent

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Douleur & Anesthésie

Paramètre 1	Douleur aiguë	Douleur chronique
Durée	< 3 mois	> 3 mois (ou > 2 mois pour la douleur chronique post-opératoire et en l'absence de complications liées à la chirurgie) Selon pédiatrie > 15 jours/mois pendant > 3 mois (ou dès que la durée dépasse l'évoluation attendue, par exemple en post-opératoire)
Fréquence	2/3 des consultations	Entre 20-50% de la population (30% selon anesthésie-réa)
Finalité biologique	Utile, Protectrice, Signal d'alarme	Inutile, Destructrice, Maladie à part entière : - Retentissement physique et psychologique -> qualité de vie
Mécanisme générateur	Unifactoriel : souvent nociceptif	Plurifactoriel persiste malgré un traitement étiologique bien conduit
Réactions somato-végétatives	Réactionnelles	Habituation ou Entretien

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 14

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 14 • Douleur & Anesthésie (210 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège des Enseignants d'Anesthésie-Réanimation & Douleur (CNEAR/SFETD)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (210 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.